

APENDICITIS AGUDA. PLASTRÓN APENDICULAR

Lourdes Galán Raposo

INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda se define como la inflamación aguda del apéndice cecal, provocada habitualmente por la obstrucción de su luz y sobreinfección bacteriana posterior. Sin un tratamiento oportuno puede evolucionar hacia la perforación apendicular, generando una peritonitis o un plastrón apendicular (masa formada por los tejidos adyacentes al apéndice perforado delimitando el proceso infeccioso). Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, con un pico de incidencia en la 2ª y 3ª década de la vida, sin diferencias entre ambos sexos.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal. En la presentación típica, el dolor se localiza inicialmente a nivel periumbilical migrando a fosa ilíaca derecha a medida que la inflamación progresa. Esto ocurre en el 50-60% de los casos. Además del dolor abdominal puede existir anorexia. En un 60-70% de los casos existen náuseas y vómitos en las primeras horas, aunque suelen ser posteriores al inicio del dolor. Si lo preceden, hay que dudar del diagnóstico de apendicitis aguda. Otros síntomas menos frecuentes son la diarrea (por irritación rectosigmoidea) y el síndrome miccional (por irritación de la vejiga urinaria). La temperatura suele alterarse a las 4-8 horas de iniciarse el cuadro, elevándose ligeramente, entre 37,5-38 °C. Se debe desconfiar del diagnóstico cuando la fiebre preceda al dolor o cuando sea superior a 39 °C sin contar con otros datos clínicos, sobre todo de palpación abdominal, sugestivos de una complicación evolutiva. En muchos pacientes los síntomas iniciales son inespecíficos (flatulencias, dispepsia, diarrea, hábito intestinal irregular, malestar generalizado).

Exploración física

Inspección

El estado general del paciente depende del tiempo de evolución del proceso. En las primeras horas suele ser bueno, evitando los movimientos innecesarios y en posición antiálgica (decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas). En las fases avanzadas el estado general suele deteriorarse.

Palpación

Destaca la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha, sobre todo en el **Punto de McBurney** (situado en la unión de 1/3 externo con los 2/3 internos de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha). La presión sobre el resto del abdomen resulta molesta, irradiándose hacia el cuadrante inferior.

Signos que podemos encontrar en relación con la irritación peritoneal

- Dolor en fosa ilíaca derecha con los movimientos, la tos o la percusión.
- Defensa muscular involuntaria a la palpación (comparar con la palpación del lado contralateral).
- Dolor producido por la descompresión brusca tras la presión (**signo de Blumberg**)
- Dolor en fosa ilíaca derecha desencadenado por la descompresión brusca en FII (**signo de Rovsing**).
- Dolor en fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera

ipsilateral (**signo del psoas**). Orienta hacia una localización apendicular retrocecal.

- Dolor en fosa ilíaca derecha con la rotación interna de la cadera con la rodilla flexionada (**signo del obturador**). Sugestivo de apendicitis pélvica.

Estos signos no son diagnósticos por sí solos.

En el caso de absceso o plastrón apendicular, puede palpase una masa con signos inflamatorios en fosa ilíaca derecha. Si existe una peritonitis aguda difusa, el dolor es intenso, generalizado y se acompaña de irritación peritoneal difusa (contractura de toda la musculatura abdominal).

Exploración ginecológica

Se debe realizar en las mujeres para descartar patología anexial.

Pruebas complementarias

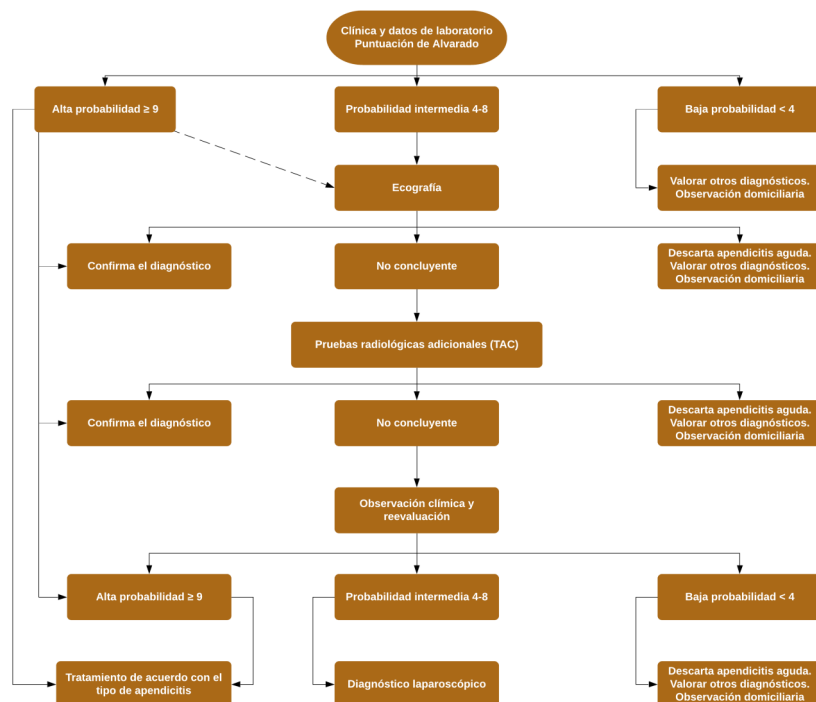
- Hemograma con recuento y formula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, lipasa, PCR, procalcitonina.
- Coagulación.
- Sistemático y sedimento de orina, en mujeres en edad fértil solicitar test de embarazo. En aproximadamente el 80% de los pacientes existe una elevación moderada en la cifra de leucocitos (leucocitosis con neutrofilia) y de los reactantes de fase aguda. No se debe olvidar el realizar un test de embarazo en mujeres en edad fértil para el diagnóstico diferencial con patología ginecológica. Las pruebas de laboratorio no sirven por sí solas para establecer el diagnóstico. En ocasiones pueden orientar a otras patologías.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral, descarta la existencia de afecciones cardiopulmonares.
- Radiografía simple de abdomen puede ser normal o presentar asa centinela o apendicolito.
- Ecografía de abdomen. Prueba de imagen de elección, una ecografía normal no excluye el diagnóstico de apendicitis aguda.
- TAC abdominal. Indicada en pacientes obesos y en ancianos por sospecha de patología tumoral o diverticular.

El diagnóstico de la apendicitis aguda es esencialmente clínico. Se han descrito escalas prácticas para el diagnóstico temprano, como la de **Alvarado** y se han propuesto algoritmos diagnóstico-terapéuticos.

Variables		Puntuación
Síntomas	• Migración del dolor a cuadrante inferior derecho • Anorexia y/o cetonuria • Náuseas y/o vómitos	• 1 • 1 • 1
Signos	• Dolor en cuadrante inferior derecho • Rebote • Elevación de la temperatura > 38°C	• 2 • 1 • 1
Laboratorio	• Leucocitosis > 10.500 por mm³ • Desviación a la izquierda de neutrófilos > 75%	• 2 • 1
Total		10

Escala de Alvarado. Puntuación para el diagnóstico de apendicitis aguda

Algoritmo diagnóstico-terapéutico propuesto por European Association for Endoscopic Surgery (EAES. Reunión de Consenso de Bucarest 2015)



Diagnóstico diferencial

Es fundamental distinguir procesos que requieran tratamiento quirúrgico

- **En niños:** linfadenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, invaginación intestinal, neumonía basal derecha.
- **En adolescentes y adultos jóvenes:** linfadenitis mesentérica, ileítis terminal, Crohn, cólico ureteral derecho.
- **En mujeres:** enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, ovulación dolorosa, rotura folicular.
- **En adultos y ancianos:** colecistitis aguda, úlcus péptico perforado, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda, cáncer de ciego, torsión de quistes o tumores ováricos*, infarto agudo de miocardio, neumonía basal, pericarditis.

* Requieren tratamiento quirúrgico.

Situaciones especiales

Apendicitis Aguda En El Niño

- Es un proceso más grave que en adulto por la alta probabilidad de perforación y el diagnóstico tardío ya que el cuadro clínico es menos típico (fiebre más alta, más vómitos y diarrea). Difícil de distinguir de la gastroenteritis aguda.

Apendicitis Aguda En El Embarazo

- Es el trastorno extrauterino más frecuente que requiere tratamiento quirúrgico durante el embarazo. Más frecuente en el primer y segundo trimestre, siendo la clínica similar a las pacientes no embarazadas. En el tercer trimestre el dolor se localiza en flanco derecho-

hipocondrio derecho por el ascenso del ciego.

Apendicitis Aguda En El Anciano

- Es un proceso grave debido a la alta frecuencia de perforación. Suele existir retraso en el diagnóstico por presentar un cuadro clínico atípico: poco frecuentes la fiebre y los vómitos.

Apendicitis Aguda En El Inmunodeprimido

- Tiene la misma incidencia que en la población general. Puede presentarse con la clínica típica, aunque es rara la presencia de leucocitosis. Se debe realizar diagnóstico diferencial con la enterocolitis neutropénica y la tiflitis por CMV.

TRATAMIENTO

- Dieta absoluta, constantes vitales, vía venosa periférica, ECG con tira de ritmo.
- Sueroterapia: Suero fisiológico 0,9% 500ml IV. o Glucosalino 500ml IV. o Glucosado al 5% 500ml IV. Según situación clínica del paciente.
- Analgesia: paracetamol 1 gr IV. o metamizol 1 amp IV o tramadol 1 amp IV o dolantina 1/2 amp IV. Según el nivel del dolor y estado clínico del paciente.
- Protección gástrica: pantoprazol 1 amp IV cada 24h.
- Valoración por el Servicio de Cirugía para tratamiento quirúrgico.

- La anamnesis y la exploración física completa son puntos fundamentales en la valoración del paciente con sospecha de apendicitis aguda.
- Se debe realizar un test de embarazo a todas las mujeres en edad fértil
- “Si náuseas, vómitos y fiebre preceden al dolor, estoy convencido de que no se trata de una apendicitis aguda” (Murphy).

BIBLIOGRAFÍA

- Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MA, Abis GS, Acharya A, Ankersmit M et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc. 2016;30(11):4668-4690.
- Townsend C, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox K. Sabiston. Tratado de Cirugía. 19ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
- Parrilla Paricio P, Landa García JI. Manual de Cirugía de la AEC. 2ª ed. médica Panamericana:Madrid;2010.